



めまい患者対応

≡ タグ

脳神経

<https://youtu.be/g6GZbR06WLM>

来院前準備

めまいで救急搬送される症例の多くはVertigoであり、そのほとんどが耳鼻科疾患であるため採血は鑑別には役立ちません。ルーチンな血液検査は不要です。

ただし、めまいの症状を落ち着けるために輸液は開始します。

当初から脳卒中が疑われる症例であれば血液検査は施行しましょう。（Af患者の急性発症など）

なお、めまいは以下のTriggerとTimingにより三通りに分けると鑑別に役立ちます。（GRACE-3 救急外来におけるめまい診療ガイドライン）

AVS	Acute vestibular syndrome	急に始まり、安静時も持続するめまいであり、24時間以上継続するもの。通常眼振が持続。	前庭神経炎か脳卒中の鑑別。HINTSが有効。眼振なしは起立歩行のチェックが大事
s-EVS	Spontaneous episodic vestibular	きっかけなく数分から数時間持続するめまいで繰	前庭性片頭痛かメニエール病を考えるが

	syndrome	り返すもの	TIAも鑑別。
t-EVS	Triggered episodic vestibular syndrome	体位で誘発される数秒から数分持続するめまいで短期間に何度も繰り返すもの	通常BPPVだが、起立性低血圧なども考慮

めまい患者の診療

動画内でも解説していますが、来院してすぐに眼を診察することが大事です。

上級医へのプレゼンも

「麻痺はなく、指鼻試験が陰性でした」というだけではなく、

「自発眼振は認められず、注視眼振も認められませんでした。頭位変換したところ、head rollでは問題ありませんでしたがDix-Hallpikeテストで右向きの際に一過性の回旋性眼振が出現しています」

のように、眼振中心の報告が望ましいです。

眼振の診察に自信のない研修医は以下のサイトで動画を確認してみましょう



めまいプロ

Kowaの提供で作られている医療者向けめまいサイト

少し古いサイトだが、眼振だけではなく耳鼻科医のめまいの診察法が動画も使い詳しい

研修医向け書籍などで一時期HINTSが有名となったため、まず「HINTS陰性です！」とプレゼンする人もいますが、HINTSはあまりERでは有用ではないことが多いです。

詳しくは動画内の解説を聞いてください。また、以下の論文（HINTSの原文）解説を確認してみましょう。

HINTSによる急性前庭症候群の診断

HINTSは上記のGRACE-3のうち、AVSでのみ有効な診察法です。BPPV疑い（tEVS）に実施するのはやめましょう。

以下を参考にしてください

眼振チェック	HINTSにかかわらずめまい診療の中心
HIT	感度特異度良好な前庭機能チェック。陽性なら前庭神経炎
Test of Skew	脳幹梗塞の有無のチェック。陽性なら脳幹梗塞疑い

HITとTest of Skew 動画リンク

まず眼を見てめまいを診断するにはSTANDINGが使用しやすいです。

ERのめまい鑑別診断 STANDING

STANDINGは以下のフローチャートです。

まず眼振の有無から開始します

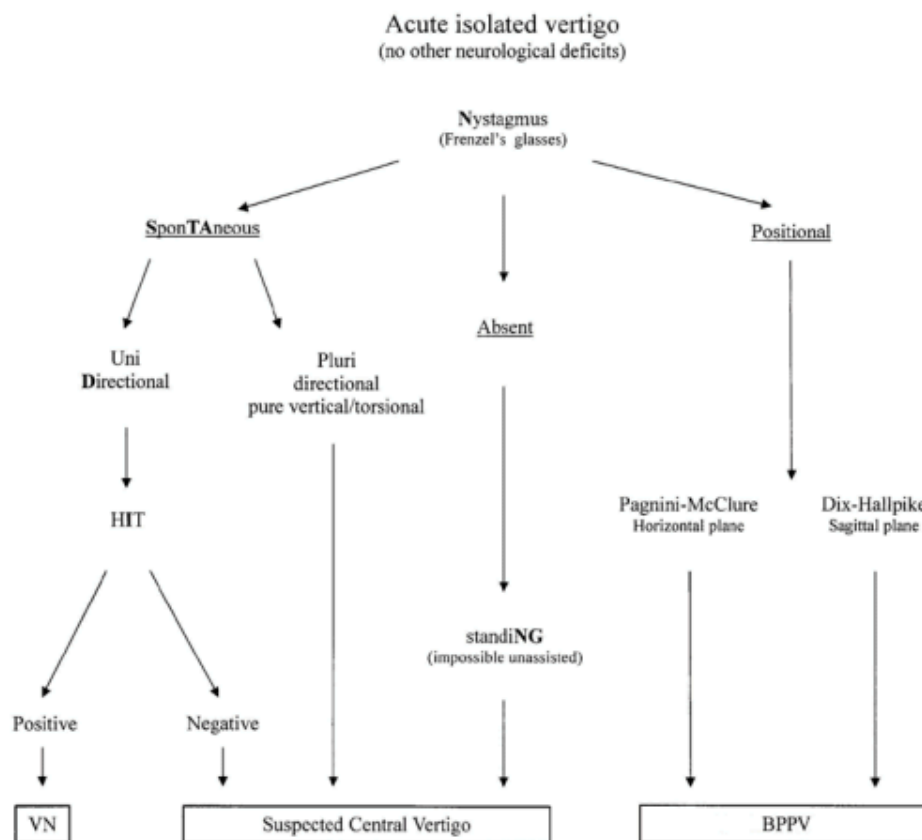


Fig. 1. Diagram of the STANDING approach. VN = Vestibular neuronitis; HIT = head impulse test; BPPV = benign paroxysmal positional vertigo.

自発眼振あり	自発眼振なし 頭位眼振なし	頭位眼振あり
眼振方向をチェック	起立歩行をチェック	Dix-Hallpike テスト

Head Impulse Test	Supine Roll テスト
-------------------	-----------------

なお、この「STANDING」という診察法名にも表れているように、**起立歩行**による失調のチェックは指鼻試験などと比較しても感度の高い診察法なので、診察あるいは方針決定において**起立歩行**は必ずチェックすること

Vertigoによる強い嘔気には以下で治療しています



めまい治療薬

アタラックスP 25 mg+生食50 mL 15分でDIV

プリンペラン1A +生食50 mL 15分でDIV

BPPVは水平半規管由来、後半規管由来の二種類あります。しっかり覚えて耳石置換法までトライしてみましょう。

	耳石置換法	手技の方向など
後半器官由来BPPV	Epley法	
水平半規管BPPV 眼振下向（向地性）	Lempert法	眼振強い方向（患側）と反対方向に360度
	Gufoni法	眼振強い方向（患側）と反対方向に倒れ、顔を下向き
水平半規管BPPV 眼振上向（背地性）	Gufoni法	眼振強い方向（健側）と反対方向に倒れ、顔を上向き

Youtubeへのリンク

Dix-Hallpike test	後半規管BPPVの診断
Supine-Head-Roll test	外側半規管BPPVの診断
Epley maneuver	後半規管BPPVの治療
Gufoni maneuver	外側半規管BPPVの治療

画像検査の適応



ペースメーカーなど禁忌がなければ以下の状況では**MRI**を考慮

1. リスクファクターのある症例の突然発症ではないか。
 - a. リスクファクター：高血圧・糖尿病・心疾患・動脈硬化・喫煙など
2. 眼振は末梢性として矛盾しないか（眼振の方向・固視による眼振減弱など）
3. 中枢性を疑わせる随伴症状や神経所見がないか
4. 起立時、歩行時のふらつきは強くないか（末梢性では片方向にふらつく程度だが、小脳失調では転んでしまう。）

帰宅可能な症例への処方例



内服処方

セファドール 6錠3× 3日分

五苓散 7.5g 3× 3日分

トラベルミン 1T1× めまい時